PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE BÁSICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 4 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

4.1 Conceitos e rede de atenção

Urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, que precisa de assistência rápida. **Emergência** é a condição que implica **risco iminente de vida** ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato (Resolução CFM nº 1.451/1995).

A Rede de Atenção às Urgências (Portaria GM/MS nº 1.600/2011, consolidada na Portaria de Consolidação nº 3/2017) é composta por: promoção e prevenção, atenção básica, **SAMU 192** e centrais de regulação, sala de estabilização, Força Nacional do SUS, **UPA 24h**, portas hospitalares de urgência, leitos de retaguarda, atenção domiciliar e hospitalar.

Classificação de risco – Protocolo de Manchester:

Cor	Prioridade	Tempo-alvo de atendimento
Vermelho	Emergência	Imediato (0 min)
Laranja	Muito urgente	10 minutos
Amarelo	Urgente	60 minutos
Verde	Pouco urgente	120 minutos
Azul	Não urgente	240 minutos

Atenção: a classificação de risco é atribuição do **enfermeiro** (Resolução COFEN nº 661/2021); o técnico em enfermagem não classifica, mas atua no acolhimento e na verificação de sinais vitais.

4.2 Suporte Básico de Vida (SBV) – Diretrizes AHA

Cadeia de sobrevivência no adulto fora do hospital: reconhecimento e acionamento do serviço de emergência → RCP de alta qualidade imediata → desfibrilação rápida (DEA) → suporte avançado → cuidados pós-PCR → recuperação.

Sequência C-A-B (compressões, via aérea, respiração). Diante de vítima que não responde:

- Verificar a segurança da cena.
- Checar responsividade (tocar os ombros e chamar em voz alta).
- Pedir ajuda, acionar o 192 e solicitar o DEA.
- Checar respiração e pulso carotídeo simultaneamente, em **no máximo 10 segundos**.
- Sem pulso e sem respiração normal (ou só gasping): iniciar RCP.

RCP de alta qualidade no adulto:

- Frequência de **100 a 120 compressões por minuto**.
- Profundidade de **5 a 6 cm**.
- Permitir o **retorno completo do tórax** após cada compressão.
- Minimizar interrupções (fração de compressões > 80%; pausas < 10 s).
- Relação **30 compressões : 2 ventilações** (1 ou 2 socorristas) sem via aérea avançada.
- Com via aérea avançada: compressões contínuas e **1 ventilação a cada 6 segundos** (10 por minuto).
- Revezar o compressor a cada **2 minutos** (ou 5 ciclos).
- Mãos no centro do tórax, na metade inferior do esterno.

Criança e lactente: relação 30:2 com 1 socorrista e **15:2 com 2 socorristas**; profundidade de cerca de 5 cm na criança e 4 cm no lactente (1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax); no lactente com 2 socorristas usa-se a técnica dos dois polegares com mãos envolvendo o tórax.

DEA (desfibrilador externo automático): ligar o aparelho → colar as pás (infraclavicular direita e lateral esquerda abaixo da axila) → afastar-se para análise → choque se indicado → retomar RCP imediatamente por 2 minutos. Ritmos chocáveis: **fibrilação ventricular (FV)** e **taquicardia ventricular sem pulso (TVSP)**. Ritmos não chocáveis: **assistolia** e **atividade elétrica sem pulso (AESP)**.

Obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE): obstrução leve (tosse eficaz) – estimular a tosse; obstrução grave em adulto e criança consciente – **manobra de Heimlich** (compressões abdominais); em lactente – **5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas**; em gestantes e obesos – compressões torácicas. Se a vítima ficar inconsciente, iniciar RCP.

4.3 Atendimento pré-hospitalar (APH) ao trauma

Avaliação primária segundo o **XABCDE** (PHTLS):

Letra	Significado	Ação
X	Hemorragia exsanguinante	Compressão direta, torniquete
A	Vias aéreas + controle da coluna cervical	Elevação do mento/tração da mandíbula, colar cervical
B	Respiração e ventilação	Avaliar FR, expansão torácica, SpO2, oferta de O2
C	Circulação e controle de outras hemorragias	Pulso, perfusão, pele, acesso venoso
D	Disfunção neurológica	Glasgow, pupilas
E	Exposição e controle da hipotermia	Despir para avaliar e aquecer

No trauma, a abertura de via aérea é feita por **tração da mandíbula (jaw thrust)**, sem hiperextensão do pescoço. A manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo é usada quando não há suspeita de trauma cervical.

Queimaduras: 1º grau (epiderme – eritema e dor), 2º grau (epiderme e parte da derme – **flictenas/bolhas**, dor intensa), 3º grau (todas as camadas – pele esbranquiçada ou carbonizada, **indolor** no centro). Extensão pela **regra dos nove** no adulto: cabeça e pescoço 9%, cada membro superior 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada membro inferior 18% e períneo 1%. Conduta inicial: interromper o processo, resfriar com **água corrente em temperatura ambiente** (nunca gelo), retirar adornos, não romper bolhas, cobrir com compressa limpa/estéril.

Hemorragias e fraturas: compressão direta é a primeira medida; o torniquete é indicado em hemorragia de membro com risco de vida. Fraturas: imobilizar a articulação acima e abaixo; não tentar realinhar fratura exposta – cobrir com curativo estéril.

4.4 Outras emergências clínicas

- **Hipoglicemia** (glicemia < 70 mg/dL): sudorese fria, tremores, confusão, convulsão. Consciente – oferecer 15 g de carboidrato de absorção rápida; inconsciente – glicose 50% EV conforme prescrição. Nunca dar líquidos pela boca a vítima inconsciente.
- **Crise convulsiva:** proteger a cabeça, afastar objetos, lateralizar após a crise, não introduzir nada na boca, não conter os movimentos, observar duração.
- **Anafilaxia:** adrenalina IM (vasto lateral da coxa) é o tratamento de primeira escolha.
- **AVC:** escala pré-hospitalar de Cincinnati (face, braço, fala) e registro do horário de início dos sintomas (janela de trombólise de até 4,5 h).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Diferença entre urgência e emergência.
- Cores e tempos do Protocolo de Manchester; classificação de risco é privativa do enfermeiro.

- Sequência C-A-B; checar pulso por até 10 s.
- RCP: 100–120/min, 5–6 cm, 30:2, retorno do tórax, troca a cada 2 min.
- 15:2 em criança/lactente com 2 socorristas.
- Ritmos chocáveis (FV e TVSP) × não chocáveis (assistolia e AESP).
- OVACE: Heimlich; lactente – 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas.
- XABCDE; tração da mandíbula no trauma.
- Classificação das queimaduras e regra dos nove; resfriar com água corrente.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Cem a cento e vinte, cinco a seis"**: frequência e profundidade das compressões.
- **"Chocável é o que treme"**: FV e TV sem pulso; "linha reta não choca" (assistolia).
- **"15 é para os pequenos com dupla"**: 15:2 em criança e lactente com 2 socorristas.
- **"X antes do A"**: hemorragia grave é contida antes da via aérea no trauma.
- **"Regra dos 9"**: cabeça 9, braço 9, frente 18, costas 18, perna 18, períneo 1.
- **"Vermelho já, laranja 10, amarelo 60, verde 120, azul 240"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a reanimação cardiopulmonar de um adulto, sem via aérea avançada, realizada por dois socorristas, recomenda-se:

(A) 15 compressões para 2 ventilações, com frequência de 80 por minuto.
(B) 30 compressões para 2 ventilações, com frequência de 100 a 120 compressões por minuto e profundidade de 5 a 6 cm.
(C) 30 compressões para 1 ventilação, com profundidade de 3 cm.
(D) compressões contínuas com 1 ventilação a cada 2 segundos.
(E) 5 compressões para 1 ventilação, com frequência de 60 por minuto.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a relação 15:2 é usada em criança e lactente com 2 socorristas, e a frequência mínima é 100/min.

B) Correta – no adulto a relação é 30:2 com 1 ou 2 socorristas, frequência de 100 a 120/min e profundidade de 5 a 6 cm.

C) Incorreta – a relação e a profundidade estão erradas.

D) Incorreta – compressões contínuas com ventilação a cada 6 segundos ocorrem apenas com via aérea avançada.

E) Incorreta – relação obsoleta e frequência insuficiente.

QUESTÃO 02

São ritmos de parada cardiorrespiratória em que está indicada a desfibrilação:

(A) assistolia e atividade elétrica sem pulso.
(B) fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
(C) bradicardia sinusal e assistolia.
(D) fibrilação atrial e flutter atrial.
(E) atividade elétrica sem pulso e fibrilação ventricular.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – assistolia e AESP são ritmos não chocáveis.

B) Correta – FV e TV sem pulso são os ritmos chocáveis.

C) Incorreta – bradicardia sinusal não é ritmo de PCR, e assistolia não é chocável.

D) Incorreta – são arritmias com pulso, tratadas de outra forma (cardioversão eletiva, quando indicada).

E) Incorreta – a AESP não é chocável.

QUESTÃO 03

Lactente de 6 meses, consciente, engasgou-se com um pedaço de alimento e não consegue chorar nem tossir. A conduta indicada é:

(A) realizar a manobra de Heimlich com compressões abdominais.
(B) fazer a varredura digital às cegas da cavidade oral.
(C) aplicar 5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões torácicas, repetindo até a desobstrução ou a perda da consciência.
(D) oferecer água para ajudar a deglutir o alimento.
(E) aguardar a tosse espontânea.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – compressões abdominais não são indicadas em lactentes, pelo risco de lesão de órgãos.

B) Incorreta – a varredura às cegas pode empurrar o corpo estranho; só se retira o objeto se estiver visível.

C) Correta – em lactente com obstrução grave alternam-se 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas.

D) Incorreta – oferecer líquidos agrava o risco de aspiração.

E) Incorreta – a ausência de choro e tosse indica obstrução grave, que exige intervenção imediata.

QUESTÃO 04

Na avaliação primária da vítima de trauma pelo método XABCDE, a letra "X" refere-se a:

(A) exame neurológico com escala de Glasgow.
(B) exposição da vítima e prevenção da hipotermia.
(C) controle de hemorragia externa exsanguinante.
(D) avaliação da via aérea com proteção da coluna cervical.
(E) radiografia da coluna cervical.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a avaliação neurológica corresponde à letra D.

B) Incorreta – exposição e controle da hipotermia correspondem à letra E.

C) Correta – o "X" prioriza o controle da hemorragia exsanguinante, que mata em poucos minutos.

D) Incorreta – via aérea com proteção cervical é a letra A.

E) Incorreta – exames de imagem não fazem parte da avaliação primária no APH.

QUESTÃO 05

Um adulto sofreu queimadura de segundo grau em todo o membro superior direito e em toda a face anterior do tronco. Pela regra dos nove, a superfície corporal queimada é de aproximadamente:

(A) 9%.
(B) 18%.
(C) 27%.
(D) 36%.
(E) 45%.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – 9% corresponde apenas ao membro superior.

B) Incorreta – 18% corresponde apenas ao tronco anterior.

C) Correta – membro superior direito (9%) + tronco anterior (18%) = 27%.

D) Incorreta – 36% seria o tronco inteiro (anterior e posterior).

E) Incorreta – valor superestimado.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: urgência × emergência; RAU (SAMU, UPA); Manchester; cadeia de sobrevivência; RCP de alta qualidade; DEA e ritmos; OVACE; XABCDE; queimaduras; hemorragias e fraturas; hipoglicemia, convulsão, anafilaxia, AVC.

Quadro-resumo: RCP 100–120/min, 5–6 cm, 30:2 (15:2 em criança com 2 socorristas); pulso em até 10 s; troca do compressor a cada 2 min; ventilação a cada 6 s com via aérea avançada; regra dos nove.

Pegadinhas: chocar assistolia; Heimlich em lactente; hiperextensão do pescoço no trauma; gelo na queimadura; técnico classificando risco.

Erros comuns: profundidade de 3 cm; esquecer o retorno completo do tórax; colocar objeto na boca durante a convulsão.